弥漫性轴索损伤个案言语康复治疗

Speech Rehabilitation Treatment of a Patient with Diffuse Axonal Injury

王嘉越　杨云凤

WANG Jia-yue, YANG Yun-feng

【摘要】弥漫性轴索损伤患者的失语认知治疗方法国内外尚无经验可循。本患者初期的临床表现与完全性失语患者相似，但又与完全性失语的损伤部位不同。在治疗过程中，把认知、呼吸构音训练做为切入点进行康复训练，同时把嘴型模仿、复述、阅读等基本的失语治疗手段融入其中，得到较好效果。在临床针对重度失语症患者的康复训练中，应通过评估找到切入点，把认知、构音、呼吸等言语所需的器官功能训练嵌入其中，会得到更好效果。

【关键词】言语康复；弥漫性轴索损伤；认知康复；完全性失语；命名性失语；构音障碍；呼吸训练

【Abstract】 The initial clinical manifestations of this patient are very similar to those of patients with complete aphasia, but differ from the site of injury in complete aphasia. In the process of treating patients, not only cognitive and respiratory articulation training was used as a starting point for rehabilitation training, but also the most basic aphasia treatment methods such as mouth shape imitation, repetition, and reading were integrated, ultimately achieving good results. Therefore, in clinical training for patients with severe aphasia, by evaluating and finding the entry point, we can embed the training of various organ functions required for speech such as cognition, articulation, and respiration, which may achieve better results.

【Key words】 Speech rehabilitation; Diffuse axonal injury; Cognitive rehabilitation; Global aphasia; Nominal aphasia; Dsarthria; Breathing training

患者男，32岁，2020年10月22日发生车祸致头部受伤、左手环小指烧伤。伤后持续意识障碍，呼之不应答。急诊头颅CT提示重度颅脑损伤，MRI提示右侧侧脑室受压变形，桥脑、右侧大脑脚、两侧侧脑室旁、两半卵圆中心见多发点片状稍长T1稍长T2信号，液体衰减反转恢复序列（fluid attenuated inversion recovery，FLAIR）高信号，磁共振弥散加权成像（diffusion-weighted imaging，DWI）等信号。脑沟、裂局部增宽，中线结构居中等。临床诊断：重度弥漫性轴索损伤。脑内血肿钻孔引流术后，患者仍中度昏迷，呈去脑强直状态，气管切开通气、鼻饲流食，对症治疗并康复治疗3个月后，患者意识逐渐恢复，

作者单位：巴彦淖尔市医院 巴彦淖尔 015000
作者简介：王嘉越 本科 康复治疗师；研究方向：言语及吞咽治疗
通讯作者：王嘉越，E-mail：624649265@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

2021年2月18日于我院康复科行康复治疗。目前患者精神饮食尚可，气切封管后，左侧偏瘫，听理解差，不能言语，不会发声，大小便失禁。本研究经巴彦淖尔市医院医学伦理委员会批准。

1 评定与治疗

患者于4月19日进行言语认知评定并训练。评定结果：简易精神状态检查量表（mini-mental state examination，MMSE）无法检测（cannot detect，NT）；听理解差。无自发语言。构音不能发声。注意力不集中，集中时间约3 s。呼吸模式：腹式呼吸微弱，呼吸浅而短。口颜面失用：面具脸模样，嘴角流涎，鼓腮吹气、缩唇不能完成。舌的各方向主动活动微弱。波士顿诊断性失语症检查（Boston diagnostic aphasia examination，BDAE）：0级。失语诊断：完全性失语。预后分析：患者目前已预后5月余，症状表现严重，短时间内难以得到语言改善，但可从认知、呼吸及发音训练入手，尝试改善认知、呼吸功能，改善口颜面失用及发音器官功能，尝试自主发音。训练计划：①提高患者注意力；②纠正口颜面失语及流涎等症状；③提高患者的听理解能力；④提高患者呼吸功能，以腹式呼吸训练为主。治疗内容：①注意力训练，使用电脑中“打地鼠”“找数字”等训练，提高患者专注力与注意力；②口颜面训练，练习唇舌、颊肌、颞肌运动与控制；③理解力训练，从所给图中找出与例图相同的图形。由2选1到多选1，难度逐步增加；④认知能力训练，学会使用杯子、毛巾等生活用品；⑤构音呼吸训练，在手法主动辅助下进行缩唇呼吸、腹式呼吸训练，提肋、降肋训练。手法激活膈肌、肋间肌，放松斜角肌、腹内外斜肌、腹直肌等辅助呼吸肌群。

上述方案治疗2个月后再次评定，结果显示：①患者注意力集中时间增加，最长可维持90 s；②口颜面失用得到部分改善，但均不充分；③部分生活可自理：会使用毛巾、杯子、筷子等物品；④构音呼吸能力改善：腹式呼吸较之前加强，可尝试发/a/音；⑤言语：复述可有嘴型动作。BDAE：0级。MMSE：NT。

根据此次评定，调整治疗方案，下一阶段（2个月）目标以提高听理解能力、构音呼吸训练、言语训练为主，口颜面训练为辅。治疗内容：①听理解训练：执行指令训练、看图匹配训练、生活用品使用训练；②构音呼吸训练：加强腹式呼吸强度、训练呼气及吸气的控制力，尽可能发/a、i、u/音；③继续加强口颜面、舌部及头颈部的力量及控制训练；④言语治疗：嘴型模仿、词语复数、简单对话。

上述方案治疗1月余后再次评定，结果显示：①患者听理解可执行简单指令，复杂指令不能完成，MMSE：10分；可用非偏瘫手完成擦脸、吃饭、刷牙等动作；②构音呼吸：被动加大腹压或牵伸膈肌时可发出/a/的长音，主动发音较小、鼻音重；③口颜面：较前有明显改善；④言语：可简单表达需求，但声音小，需要听者猜测。治疗效果明显，继续调整治疗方案，下阶段以提高听理解能力、言语表达和构音训练为主。

患者于9月15日出院，出院评定：BDAE3级，言语欠流利、声音不高，但可交流及应答。MMSE20分，汉语失语症评定量表测验结果为流畅67%、听辨认80、复述90，考虑命名性失语，构音问题仍存在。嘱患者回家后继续进行呼吸及命名训练与阅读训练，提高

中国知网 https://www.cnki.net

词汇量。

2 讨论

弥漫性轴索损伤是闭合性颅脑损伤中常见的损伤形式之一，多见于交通事故，一般中间无清醒期，伤后立即陷入持续昏迷，去大脑强直或去皮质强直，可导致认知功能、运动功能及感觉功能障碍。根据损伤后的严重程度可分为轻度、中度、重度3种类型[1,2]。其中均可出现外伤后昏迷，伴或不伴去大脑强直/去皮质强直，且在昏迷阶段无法进行鉴别。可根据患者昏迷持续时间、出现去大脑/去皮质强直发生占比、预后等要点判断患者损伤严重程度[1]。

有关弥漫性轴索损伤患者的失语认知治疗方法在国内外尚无经验可循。本研究患者初期临床表现和完全性失语患者相似，无自发性言语、听理解差、复述差，但又与完全性失语的损伤部位不同。笔者在治疗过程中把认知、呼吸构音训练作为切入点，在训练同时，不仅把所属的器官功能及其肌肉进行放松，逐个训练，还把嘴型模仿、复述、阅读等基本的失语治疗手段融入其中，最终取得较好效果。由此，在临床针对重度失语症患者的康复训练中，通过评估找到切入点，可把认知、构音、呼吸等言语所需的各器官功能训练嵌入其中，也许会得到更好的效果。该方法可能适用于其他弥漫性轴索损伤患者及中重度失语症患者的治疗。

参考文献

[1] 张有良，刘良，任亮.弥漫性轴索损伤病理改变及病理生理机制的研究进展[J].中西医结合心脑血管病杂志，2021，19(1)：73-76.

[2] 从斌.法医病理学5版[M].北京：人民卫生出版社，2016：169-170.

中国知网 https://www.cnki.net